

表2 Palliative Prognostic Index (PPI)

項目		得点
Palliative Performance Scale	10~20 (常に臥床, 全介助)	4.0
	30~50 (ほとんど臥床, しばしば介助)	2.5
経口摂取	著明に低下	2.5
	中程度低下	1.0
浮腫	あり	1.0
安静時呼吸困難	あり	3.5
せん妄	あり	4.0

(Morita T, et al : Support Care Cancer 7 : 128, 1999 より引用)

ている場合も「レスキュー頻回」となりがちだが、せん妄対策をせずにオピオイドを増量すると症状はさらに悪化するので要注意である。

3 せん妄の症状マネジメント

せん妄はがん患者の終末期では80%以上に生じるとされ、本人のみならず家族にとっても多大な苦痛となるため早期のアセスメントと対策が重要である。幻覚や妄想が顕著な過活動型の診断は容易だが、日中傾眠傾向の低活動型の場合には見過ごされることも多い。基本的には認知機能障害があり、「つじつまの合わない会話」や「場所や日時が答えられない」症状が「1日の中で変動する」場合はほぼせん妄で間違いのない(日々の診察の中で上記をさりげなく確認することが重要である)。せん妄の原因として、高カルシウム血症や感染症、直近に開始・増量したオピオイドや睡眠薬・ステロイドなどの薬剤が疑わしい場合には、原因病態に対する治療や当該薬剤の調整で回復する場合もあるが、癌の進行に伴う全身状態の悪化が原因の場合は不可逆性であることも多い。せん妄時にまず行うべきは環境因子の調整であり、さらに必要に応じてhaloperidolやrisperidone, quetiapineなどの抗精神病薬を少量(quetiapineの場合1回25mg)から開始し、症状の程度に合わせて適宜増量(もしくは症状増悪時に頓用)する。

可逆性のせん妄と判断される場合には、増悪因子で

あるベンゾジアゼピン系の睡眠薬は極力控えるべきだが、不可逆性せん妄の場合には患者および家族の休息のため、抗精神病薬併用下でベンゾジアゼピン系薬剤を用いるのも妥当とされる。重症の場合はいわゆる「持続的鎮静」が必要となる場合もあるが、その際は主治医のみで判断せず、緩和ケアチームや精神科医にも相談のうえ慎重に対処するのが望ましい。いずれにせよ、変貌してしまった患者の姿に家族は少なからず精神的苦痛を感じるため、「患者自身には何の落ち度もなく」「(多くの場合)麻薬のせいでもなく」、癌の進行による全身の衰弱が主因であることを丁寧に説明し、適切な治療で症状を和らげることができることを伝えて安心してもらうのが主治医の大事な役目である。

4 その他に留意すべきこと

終末期の検査や薬物療法に際しては、予後に応じて無為な負担をかけない選択が重要である。表2に示すPalliative Prognostic Index (PPI)が6.5点以上の場合、予後は21日以下(週単位)である可能性が高く、侵襲的な検査や処置(胸水ドレナージなど)、500 mLを超える過剰な輸液などは控えるのが妥当である⁵⁾。輸液が少量となれば、患者の負担にならない皮下輸液が可能である。多くの薬剤(鎮痛薬、ステロイド、睡眠薬、抗精神病薬など)も皮下投与が可能であり、患者のみならず医療者の負担軽減にもつながるので積極的に活用されたい。以上に示した諸々のメリットは、緩和ケアの専門施設で研修すれば必ず実感できるので、呼吸器専門医を目指す方は是非ご検討いただきたい。

文 献

- 1) Temel JS, et al : N Engl J Med 363 : 733, 2010
- 2) Gilligan T, et al : J Clin Oncol 35 : 3618, 2017
- 3) Fujimori M, et al : J Clin Oncol 32 : 2166, 2014
- 4) 井上 彰 (監) : 東北大学病院緩和ケア BOOK, 中外医学社, 2022
- 5) Morita T, et al : Support Care Cancer 7 : 128, 1999